Comprendre les réalités et les lacunes en matière de santé menstruelle chez les personnes intersexuées au Nigeria.

Par Intersex Nigeria
(Center for Healthcare Development and Youth Empowerment)



In collaboration with

In partnership with

Contact Information

Intersex Nigeria
(Center for Healthcare Development and Youth Empowerment)

Lagos and Abuja, Nigeria

info@intersexnigeria.org

Visit our website

www.intersexnigeria.org

Social Media

@Intersex_nigeria_

@IntersexNigeria

@IntersexNigeria

Intersex Nigeria

Published by: Intersex Nigeria
Copyright: Intersex Nigeria, May 2026

TABLE DES MATIÈRES

Liste des graphiques et tableaux 3
Avant-propos 4
Remerciements 5
Résumé 6
Acronymes 7

Introduction **8**

Contexte de l'étude 8
Énoncé du problème 9
Objectifs de l'étude 9
Questions de recherche 9
Importance de l'étude 10

Revue de la littérature **11**

Comprendre les variations intersexuées et les besoins en matière de soins de santé 11
Santé menstruelle et cadre inclusif 11
La menstruation chez les personnes intersexuées 12
Prestataires de soins de santé et services de santé sexuelle et reproductive inclusifs pour les personnes intersexuées 13
Lacunes politiques et obstacles à l'inclusion des personnes intersexuées en matière de santé menstruelle au Nigeria 14
Intersexualité et difficultés d'accès aux soins de santé 15

Méthodologie **16**

Conception de l'étude 16
Population étudiée 16
Technique d'échantillonnage et taille de l'échantillon 17
Méthodes de collecte des données 17
Considérations éthiques 17

Résultats et analyse **18**

Profil démographique des professionnels de santé ayant participé à l'enquête
Inclure les données démographiques des personnes intersexuées ayant participé à la recherche 18
Sensibilisation et connaissances en matière de santé menstruelle des personnes intersexuées 19
Accès à l'information et aux produits menstruels 20
Interactions avec les professionnels de santé 21
Impact psychosocial et stigmatisation 21
Attitudes et lacunes dans la prestation des services 21
Rencontres des professionnels de santé avec une patiente intersexuée sollicitant des soins pour des problèmes menstruels ou connexes 22
Confiance dans la prestation de soins menstruels 22
Obstacles à des soins inclusifs 23
Inclusion et lacunes politiques 24

Discussion, conclusions et recommandations **25**

Discussion des résultats 25
Conclusions 25
Recommendations 27

Références **30**

Liste des graphiques et tableaux

Figure 1 : Professionnels de santé par rôle professionnel
Figure 2 : Professionnels de santé par années d'expérience
Figure 3 : Connaissance du terme « intersexué » par les professionnels de santé
Figure 4 : Professionnels de santé ayant suivi une formation sur la santé des personnes intersexuées
Figure 5 : Perception des professionnels de santé concernant les menstruations chez les personnes intersexuées
Figure 6 : Montre les professionnels de santé ayant rencontré des personnes intersexuées présentant des troubles menstruels
Figure 7 : Confiance des professionnels de santé dans la prise en charge des soins menstruels des patients intersexués
Figure 8 : Réponses des professionnels de santé concernant l'existence de directives claires sur le lieu de travail relatives à la santé menstruelle des personnes intersexuées
Figure 9 : Réponses concernant la réception par les professionnels de santé de protocoles cliniques ou de ressources relatifs à la santé menstruelle des personnes intersexuées
Figure 10 : Réponses concernant les obstacles à l'inclusion des personnes intersexuées dans les soins de santé menstruelle
Figure 12 : Réponses concernant le soutien nécessaire pour améliorer les soins prodigués aux personnes intersexuées qui ont des règles

Avant-propos

La santé menstruelle est de plus en plus reconnue comme un pilier de la santé sexuelle et reproductive, de la dignité humaine et de l'égalité des genres. Pourtant, malgré les progrès mondiaux, d'importantes lacunes subsistent pour garantir que toutes les personnes qui ont leurs règles soient reconnues et soutenues au sein des systèmes de santé. Parmi les plus invisibles dans ces discussions figurent les personnes intersexuées, dont les besoins uniques et les expériences vécues sont souvent réduits au silence par des cadres binaires rigides, la stigmatisation et la négligence systémique.

Cette recherche ouvre de nouvelles perspectives en mettant en lumière les réalités de la santé menstruelle des personnes intersexuées au Nigeria, un sujet qui est resté largement inexploré. En mettant en avant les voix des personnes intersexuées et en impliquant les professionnels de santé, l'étude met en évidence les obstacles multiples liés à une prise de conscience limitée, à la stigmatisation, à une formation inadéquate et à l'exclusion politique qui empêchent les personnes intersexuées d'accéder à des soins équitables. Elle souligne également les dimensions psychosociales de la menstruation, révélant le secret, la honte et l'isolement que subissent de nombreuses personnes intersexuées, ainsi que la résilience de celles qui trouvent un soutien au sein de leur famille ou de leur communauté.

Ces conclusions sont non seulement d'actualité, mais aussi urgentes. Elles fournissent des preuves claires que l'inclusion des personnes intersexuées dans la santé menstruelle est à la fois un impératif en matière de droits humains et une nécessité de santé publique. Les recommandations proposées, qui couvrent l'éducation, la formation des professionnels de santé, la réforme des politiques et le soutien psychosocial, présentent une feuille de route pour la mise en place d'un système de santé inclusif, respectueux et adapté aux besoins de tous.

Cette étude constituera une ressource essentielle pour les décideurs politiques, les professionnels de santé, les défenseurs des droits et les chercheurs engagés dans la promotion de l'équité en matière de santé. Plus important encore, elle amplifie la voix des personnes intersexuées qui, depuis trop longtemps, ont été exclues des discussions concernant leur propre corps et leurs droits.

Nous espérons que cette recherche inspirera un dialogue national et des actions concrètes en faveur d'un avenir inclusif où chaque personne qui a ses règles sera soutenue, respectée et autonomisée.

Remerciements

Intersex Nigeria (Centre for Healthcare Development and Youth Empowerment) exprime sa sincère gratitude à toutes les personnes intersexuées et à tous les professionnels de santé qui ont contribué à cette recherche. Votre courage, votre ouverture d'esprit et votre volonté de partager vos expériences vécues constituent le fondement de ce travail. En partageant vos histoires et vos réflexions, vous avez brisé le silence et donné de la visibilité à une question trop souvent ignorée.

Nous tenons à exprimer notre gratitude la plus sincère et la plus profonde à nos principaux bailleurs de fonds, Fos Feminista et l'Agence française de développement (AFD), dont le soutien a permis de concrétiser le projet Sang Pour Sang. Nous vous sommes extrêmement reconnaissantes pour votre partenariat indéfectible et pour avoir reconnu le besoin crucial d'une recherche menée par des personnes intersexuées. Votre engagement en faveur de la justice reproductive et des droits des personnes marginalisées a fourni les bases nécessaires à l'épanouissement de ce projet. En investissant dans ce travail, vous nous avez donné les moyens de lutter contre les inégalités systémiques et de mettre en avant les voix de celles et ceux qui sont souvent relégués en marge des soins de santé et des droits humains.

Le soutien de Fos Feminista et de l'Agence française de développement (AFD) a joué un rôle déterminant pour combler le fossé entre la recherche et l'impact social. Nous apprécions votre dévouement en faveur d'un développement inclusif et votre conviction qu'un avenir où les soins de santé sont un droit et non un privilège est possible. Grâce à votre financement, nous avons pu produire un ensemble de données factuelles qui, nous en sommes convaincus, servira de catalyseur pour le changement politique et la justice sociale au Nigeria dans les années à venir.

À travers le projet Sang Pour Sang, Fos Feminista et l'Agence française de développement (AFD) ont fait bien plus que financer un rapport ; vous avez fourni une plateforme pour faire éclater la vérité et un catalyseur pour un changement systémique au sein des paysages sanitaires et sociaux du Nigeria.
Nous sommes profondément reconnaissants envers nos consultants, Parton Titus et Moses Danjuma Kusko, pour leur engagement sans faille, leur passion et leur expertise. Leur dévouement reflète le pouvoir de la recherche, non seulement pour informer, mais aussi pour lutter contre la stigmatisation, changer les discours et susciter un changement social significatif.

Nos sincères remerciements vont aux personnes intersexuées qui ont cru en ce projet et ont partagé leurs histoires pour garantir l'authenticité du rapport ; votre soutien a été déterminant pour rendre ce projet possible. Votre engagement envers le mouvement intersexué a amplifié les voix des personnes intersexuées au Nigeria et réaffirmé que l'inclusion et l'équité doivent rester au cœur de la santé et des droits humains. Grâce à votre expérience vécue et à votre dévouement inébranlable à la promotion des droits, de la dignité et du bien-être des personnes intersexuées, vous continuez à inspirer et à façonner un changement significatif au-delà de nos engagements.
Enfin, à toute l'équipe d'Intersex Nigeria, merci pour votre résilience, votre plaidoyer et votre détermination qui ont permis de concrétiser ce travail. Cette recherche est une réussite collective, qui nous rapproche d'un Nigeria où les personnes intersexuées sont reconnues, respectées et autonomisées.

Résumé

Cette étude explore les besoins et les expériences en matière de santé menstruelle des personnes intersexuées au Nigeria et évalue les connaissances, les attitudes et les pratiques des professionnels de santé (PS) dans la prestation de soins inclusifs pour les personnes intersexuées. Malgré l'attention croissante portée à la santé menstruelle à l'échelle mondiale, les personnes intersexuées restent largement exclues de la recherche, des discours, des politiques et des programmes. Cette invisibilité se traduit par des besoins de santé non satisfaits, des difficultés psychosociales et une exclusion systémique au sein du paysage de la santé sexuelle et reproductive (SSR) au Nigeria. Alors que la plupart des professionnels de santé avaient entendu parler de l'intersexualité, seuls 15 % avaient reçu une formation formelle, et à peine 6 % avaient déjà eu accès à des protocoles cliniques sur les soins aux personnes intersexuées. Les personnes intersexuées ont également indiqué avoir appris la menstruation de manière informelle, souvent par le biais de leurs pairs ou de leur famille, avec peu ou pas d'éducation précise ou inclusive.

Les participants intersexués et les professionnels de santé ont tous deux identifié la stigmatisation et le jugement comme des obstacles majeurs. Avec 77 % des professionnels de santé citant la stigmatisation comme un défi clé, l'étude révèle comment les cadres binaires de la santé sexuelle et reproductive et les préjugés sociétaux renforcent l'invisibilité et découragent les personnes intersexuées de rechercher des soins. Près de la moitié des professionnels de santé ont identifié les lacunes politiques comme un obstacle, beaucoup soulignant que la santé des personnes intersexuées est absente des politiques et programmes de santé sexuelle et reproductive. En l'absence d'une inclusion formelle, la prestation de services reste inégale et exclusive. Les personnes intersexuées ont décrit le secret, la honte et les conflits intérieurs liés aux menstruations, souvent associés à des normes de genre rigides. Si certaines bénéficiaient d'un soutien familial, la plupart ne disposaient pas de réseaux communautaires ou de groupes de pairs, ce qui accroît leur vulnérabilité à l'isolement et à des problèmes de santé mentale.

L'étude conclut que les personnes intersexuées au Nigeria sont confrontées à des obstacles multiples, allant d'une éducation inadéquate et de politiques d'exclusion à la stigmatisation par les prestataires et à la négligence systémique. Parallèlement, les professionnels de santé se disent prêts à améliorer leur capacité à fournir des soins inclusifs, soulignant le besoin de formation médicale continue, de mentorat par des spécialistes et de directives cliniques nationales.

Cette recherche fournit les premières données ciblées sur la santé menstruelle des personnes intersexuées au Nigeria, mettant en évidence des lacunes urgentes en matière de connaissances, de politiques et de prestation de services. Elle montre qu'une santé menstruelle inclusive est à la fois un impératif en matière de droits humains et une nécessité de santé publique. Lutter contre la stigmatisation, renforcer les capacités des prestataires et intégrer les réalités intersexuées dans les politiques permettra de garantir que les personnes intersexuées ne soient plus invisibles dans le système de santé nigérian.

Acronyms

AIS – Syndrome d'insensibilité aux androgènes
CAH – Hyperplasie congénitale des surrénales
HCW – Professionnel de santé
IPA – Analyse phénoménologique interprétative
KII – Entretien avec un informateur clé
MRKH – Syndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser
SRH – Santé sexuelle et reproductive
UNFE – Campagne « Libres et égaux » des Nations Unies
HCDH – Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
WASH – Eau, assainissement et hygiène
OMS – Organisation mondiale de la santé
CHEW – Agent de vulgarisation sanitaire communautaire

01

Introduction

Contexte de l'étude

Le terme « intersexué » est un terme générique utilisé pour décrire les personnes nées avec des caractéristiques sexuelles physiques et biologiques, telles que les chromosomes, les hormones, les gonades ou les organes génitaux, qui ne correspondent pas aux notions binaires typiques des corps masculins ou féminins. Ces variations peuvent être apparentes à la naissance, devenir visibles à la puberté ou rester indétectables à moins d'être identifiées par des examens médicaux. Plus de 40 variations intersexuées ont été répertoriées et, selon la campagne « Free & Equal » des Nations Unies, entre 0,05 % et 1,7 % de la population mondiale naît avec des caractéristiques intersexuées (UNFE, 2017 ; HRW, 2024).

Bien qu'elles fassent naturellement partie de la diversité humaine, les personnes intersexuées sont souvent confrontées à une stigmatisation importante, à la discrimination et à des violations des droits humains.

Parmi celles-ci figurent les pratiques médicales et les interventions chirurgicales non consenties et préjudiciables, l'accès limité à des informations fiables, une reconnaissance juridique restreinte, l'exclusion des lois anti-discrimination, les obstacles à l'obtention de documents d'identité précis, l'insuffisance des mécanismes de recours juridiques, le déni du droit à l'auto-identification et l'exclusion systémique des services de santé (HRW, 2017). Dans de nombreuses sociétés, y compris au Nigeria, des normes binaires profondément enracinées en matière de sexe et de genre contribuent à l'invisibilité et à la marginalisation accrue des personnes intersexuées, en particulier au sein des systèmes de santé et des cadres politiques qui ne reconnaissent pas leur existence.

La santé menstruelle, traditionnellement envisagée dans le cadre des expériences des femmes et des filles cisgenres, constitue un sujet de préoccupation majeur. Cela met en évidence l'absence d'inclusion des personnes intersexuées dans les politiques et l'éducation en matière de santé menstruelle.

Les recherches sur les politiques de santé menstruelle au Nigeria se concentrent principalement sur les adolescentes et les femmes (Olasehinde, 2025). Ce cadre exclut souvent les personnes intersexuées assignées de sexe masculin à la naissance qui ont des règles ou qui sont confrontées à des problèmes de santé liés aux menstruations. Ce cadre d'exclusion entraîne un déficit important en matière d'éducation, de produits et de soins de santé menstruels adaptés pour de nombreuses personnes intersexuées au Nigeria, ce qui se traduit souvent par de la honte, de la confusion, des troubles de santé mentale et une autonomie corporelle réduite.

La santé menstruelle est un état de bien-être physique, mental et social complet lié au cycle menstruel d'une personne. Elle inclut l'accès à des informations précises, à des produits menstruels abordables, à des installations sanitaires propres et sûres, à des services de santé adaptés aux préoccupations menstruelles, y compris la douleur et l'irrégularité, ainsi qu'à un environnement exempt de stigmatisation.



Les cadres internationaux reconnaissent désormais que la santé menstruelle s'applique à toutes les personnes qui ont leurs règles, et pas seulement aux femmes et aux filles, et appellent à des approches inclusives qui respectent la diversité des caractéristiques de genre et de sexe (Åkerman, 2024).

Pour les personnes intersexuées, les besoins en matière de santé menstruelle sont particulièrement complexes. Selon la variation intersexuée spécifique, les personnes peuvent présenter une anatomie reproductive qui permet et subit les menstruations, comme dans les cas d'hyperplasie congénitale des surrénales ou de différences ovotesticulaires 46, XX, ou ne pas avoir de menstruations du tout, comme celles atteintes du syndrome d'insensibilité totale aux androgènes, du syndrome de Mayer–Rokitansky–Küster–Hauser ou du syndrome de Turner (Mazur et al., 2009)

Les recherches et les données sur la santé menstruelle au sein des populations intersexuées, en particulier en Afrique, restent rares. Ce manque d'attention limite l'élaboration de politiques et de programmes inclusifs en matière de santé sexuelle et reproductive qui tiennent compte des réalités diverses des personnes intersexuées. En conséquence, les personnes intersexuées au Nigeria continuent de faire face à l'invisibilité, à la négligence médicale et à l'exclusion socioculturelle dans le domaine de la santé menstruelle.

Exposé du problème

La santé menstruelle au Nigeria a gagné en visibilité ces dernières années, mais cette attention ne s'est pas traduite par une inclusion de toutes les personnes qui ont leurs règles. Les personnes intersexuées restent exclues des débats nationaux, des politiques et des réponses programmatiques en matière de gestion de l'hygiène menstruelle. L'absence de recherche et de données fiables aggrave encore leur exclusion.

Les professionnels de santé, qui jouent un rôle essentiel dans la garantie de la santé menstruelle, ont souvent une connaissance limitée, voire inexistante, des besoins de santé spécifiques aux personnes intersexuées. Par conséquent, les personnes intersexuées qui ont leurs règles sont généralement confrontées à la confusion, à des erreurs de diagnostic, voire à une stigmatisation pure et simple et à des soins inadéquats lorsqu'elles accèdent aux services de santé. Ces lacunes portent atteinte à leur droit à des soins de santé menstruelle sûrs, dignes et valorisants.

Cette recherche répond au besoin urgent de comprendre et de documenter les expériences en matière de santé menstruelle des personnes intersexuées au Nigeria, tout en évaluant les connaissances, les attitudes et les pratiques des prestataires de soins de santé concernant les besoins de santé menstruelle des personnes intersexuées. Les résultats de cette recherche visent à éclairer les politiques, à renforcer les capacités des prestataires de soins de santé et à soutenir l'élaboration de programmes de santé menstruelle inclusifs et fondés sur les droits.

Objectifs de l'étude

Objectif principal

Explorer les besoins en matière de santé menstruelle des personnes intersexuées au Nigeria et évaluer la capacité des professionnels de santé à fournir des soins inclusifs et adaptés aux personnes intersexuées.

Objectifs spécifiques

- Documenter les expériences vécues en matière de santé menstruelle par les personnes intersexuées au Nigeria.
- Évaluer la sensibilisation et la réactivité des prestataires de soins de santé à l'égard des soins de santé menstruelle des personnes intersexuées.

- Identifier les lacunes systémiques, institutionnelles et politiques liées aux services de santé menstruelle inclusifs pour les personnes intersexuées.
- Formuler des recommandations concrètes et fondées sur des données probantes pour améliorer l'inclusion des personnes intersexuées dans les politiques et les pratiques en matière de santé menstruelle.

Questions de recherche

I. Quelles sont les diverses expériences vécues en matière de menstruation chez les personnes présentant des variations innées des caractéristiques sexuelles au Nigeria ?
II. Dans quelle mesure les professionnels de santé sont-ils informés des besoins en matière de santé menstruelle des personnes intersexuées au Nigeria ?
III. Quelles sont les principales lacunes dans la prestation des services de santé et les politiques publiques existantes qui entravent la mise en place d'un soutien adéquat et inclusif en matière de santé menstruelle pour les personnes intersexuées au Nigeria ?
IV. Quelles recommandations spécifiques et concrètes peuvent être formulées pour renforcer l'inclusion des personnes intersexuées dans les politiques, les pratiques et les cadres de prestation de services de santé menstruelle au Nigeria ?

Importance de l'étude

Cette étude fournira des données ciblées sur la santé menstruelle des personnes intersexuées au Nigeria, offrant une occasion unique de :

- Contribuer à l'intégration de politiques en matière de santé sexuelle et reproductive (SSR) et de programmes de formation en soins de santé tenant compte des personnes intersexuées.
- Donner aux groupes de personnes intersexuées les moyens d'agir en leur fournissant des outils et des données pour mener leurs actions de plaidoyer
- Sensibiliser les principales parties prenantes aux besoins négligés des personnes intersexuées.



02

Revue de la littérature

Comprendre les variations intersexuées et les besoins en matière de soins de santé

Les personnes intersexuées naissent avec des caractéristiques sexuelles innées qui ne correspondent pas aux définitions typiques des corps masculins ou féminins. Il peut s'agir de variations au niveau des chromosomes, des gonades, des hormones ou des organes génitaux (UNFE, 2017). Ces variations biologiques peuvent être évidentes à la naissance ou devenir perceptibles plus tard dans la vie, par exemple à la puberté (Woodward & Neilson, 2013). Plus de 40 variations intersexuées ont été répertoriées à l'échelle mondiale, notamment l'hyperplasie congénitale des surrénales (HCS), le syndrome d'insensibilité aux androgènes (SIA), le syndrome de Klinefelter, le syndrome de Turner et le syndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH), selon l'organisation de défense des personnes intersexuées interACT (Eleesha 2024). Ces variations peuvent entraîner un large éventail de développements reproductifs et hormonaux, ce qui a des répercussions sur la santé sexuelle et reproductive, y compris les menstruations.

Des études ont montré que la prise en charge clinique des personnes intersexuées, en particulier dans les pays du Sud, implique souvent une attribution précoce d'un genre et des chirurgies génitales irréversibles sans consentement éclairé (Boyle et al., 2005 ; Rebelo et al., 2008). Ces interventions, bien que justifiées médicalement au nom de la « normalisation », ont des conséquences physiques et psychologiques à long terme, notamment des traumatismes, une confusion identitaire et une dysphorie de genre (Chadwick et al., 2005).

À l'échelle mondiale, les personnes intersexuées sont victimes de discrimination dans les contextes médicaux, juridiques et sociaux (Human Rights Watch, 2017). En particulier, les interventions chirurgicales non consenties et médicalement inutiles pratiquées sur des nourrissons et des enfants intersexués ont été condamnées par les organes des Nations Unies chargés des droits de l'homme comme des violations de l'autonomie corporelle (HCDH, 2015).

Les systèmes de santé fonctionnent souvent sur la base d'hypothèses binaires concernant le sexe, rendant les expériences intersexuées invisibles ou pathologisées.

Santé menstruelle et cadre inclusif

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) appelle à la reconnaissance et à la définition de la menstruation comme une question de santé (et non d'hygiène) comportant des dimensions physiques, psychologiques et sociales, et qui doit être abordée dans la perspective d'un parcours de vie allant de la pré-menarche à la post-ménopause. L'OMS demande que la santé menstruelle soit reconnue, définie et traitée comme une question de santé et de droits humains, et non comme une question d'hygiène ; la santé menstruelle signifie que les femmes, les filles et les autres personnes qui ont leurs règles ont accès à l'information et à l'éducation sur la menstruation ;

Au Nigeria, la menstruation est souvent entourée de tabous et de silence. De nombreuses communautés considèrent les femmes menstruées comme rituellement impures ou restreignent leurs activités. Par exemple, des Nigérianes plus âgées racontent que, par le passé, les mères avaient souvent peur de dire aux pères que leurs filles avaient leurs règles, de crainte qu'ils ne reprochent aux filles d'avoir fait quelque chose de mal. On sait que des maris évitaient leurs épouses ou refusaient même de manger la nourriture préparée par les femmes pendant leurs règles (Plan International USA, 2024).

Ces attitudes culturelles, associées à des infrastructures limitées en matière d'eau et d'assainissement, contribuent à ce que les observateurs appellent la « précarité menstruelle » et à la honte omniprésente entourant les règles. Une étude a révélé que 23 % des adolescentes nigérianes manquaient l'école en raison de difficultés liées aux règles (Nigeria Health Watch, 2025), ce qui reflète le manque d'intimité, de produits et de compréhension bienveillante à l'école et à la maison.

Ces tabous généraux liés aux menstruations se recoupent avec les opinions conservatrices du Nigeria sur le sexe et le genre. Les variations intersexuées sont largement méconnues du grand public : les croyances traditionnelles peuvent considérer les traits intersexués comme des malédictions ou de mauvais présages (Outright International, 2024). Les personnes intersexuées n'ont pratiquement aucune visibilité ni reconnaissance dans la législation ou la politique de santé nigérianes. Ce n'est que très récemment, en 2024–2025, que le ministère fédéral de la Santé a commencé à "lancer un débat national" sur l'inclusion des personnes intersexuées. Les responsables ont admis qu'il n'existait aucune donnée nationale sur la prévalence de l'intersexualité et que presque tous les cas n'étaient pas documentés ou n'étaient identifiés que dans les hôpitaux tertiaires. À ce jour, il n'existe aucune politique spécifique pour la santé des personnes intersexuées (thenationonline, 2025).

La santé menstruelle est de plus en plus reconnue comme une question de santé publique et de droits humains. L'Organisation mondiale de la santé définit la santé menstruelle comme un état de bien-être physique, mental et social lié au cycle menstruel, et non simplement comme l'absence de maladie ou de gêne (OMS, 2022).
Des recherches récentes ont documenté les expériences uniques en matière de santé menstruelle des personnes trans et intersexuées, notamment la détresse psychologique, l'isolement social et le refus de services en raison d'une présentation de genre non conforme (Dubey et al., 2024 ; Muskan T, 2024). Cela montre l'importance de politiques intersectionnelles et inclusives.



> ***"L'Organisation mondiale de la santé définit la santé menstruelle comme un état de bien-être physique, mental et social concernant le cycle menstruel, et non pas simplement l'absence de maladie ou d'inconfort (OMS, 2022)."***

La menstruation chez les personnes intersexuées

La menstruation, souvent perçue comme une expérience exclusivement réservée aux femmes cisgenres, est un phénomène complexe et souvent pénible chez certaines personnes intersexuées. Selon la variation intersexuée spécifique, les personnes intersexuées peuvent présenter des saignements réguliers (par exemple, les personnes 46, XX atteintes d'hyperplasie congénitale des surrénales) ou aucun saignement (par exemple, AIS, syndrome de Turner) (Malouf et al., 2010), ou encore des règles irrégulières. Dans certains cas rares, des personnes assignées de sexe masculin à la naissance peuvent présenter des tissus utérins ou vaginaux et signaler des saignements inexpliqués (Hutson et al., 2012). Les personnes atteintes du syndrome AIS ou du syndrome de MRKH ont généralement des chromosomes XX mais n'ont pas de règles en raison de l'absence d'organes reproducteurs

> ***"Des recherches récentes ont mis en lumière les expériences menstruelles spécifiques vécues par les personnes trans et intersexes, notamment la détresse psychologique, l'isolement social et le refus de services en raison d'une expression de genre non conforme (Dubey et al., 2024 ; Muskan T, 2024). Ceci souligne l'importance de politiques intersectionnelles et inclusives."***

féminins internes. Dans certains cas, les personnes présentant des organes génitaux ambigus peuvent présenter des saignements vaginaux sans en comprendre l'origine en raison d'un manque de conseils médicaux appropriés (Lee et al., 2006).

Cependant, les études portant spécifiquement sur la menstruation chez les personnes intersexuées sont rares. Dans les études qualitatives existantes, les personnes intersexuées font état de confusion, d'isolement et de honte liés à la menstruation, en particulier lorsque les professionnels de santé manquent de connaissances ou de sensibilité (Sanders & Carter, 2015). Dans les contextes à faibles ressources comme le Nigeria, cette invisibilité est encore plus prononcée en raison de la faiblesse des infrastructures de santé sexuelle et reproductive (SSR), de la rigidité des binaires de genre et des niveaux élevés de stigmatisation (Warne & Raza, 2008).

La diversité des expériences intersexuées remet en question les cadres médicaux et politiques qui traitent la menstruation comme un phénomène uniforme. L'invisibilité dans le discours sur la menstruation aggrave la confusion, la honte et le manque d'accès à des soins appropriés. Des études soulignent que les personnes intersexuées se sentent souvent exclues tant des espaces de santé destinés aux femmes que des systèmes de santé généraux (Jones et al., 2016).

Il existe un manque flagrant de données sur la manière dont les personnes intersexuées vivent et gèrent leurs menstruations au Nigeria, et celles qui ont leurs règles le font souvent en secret en raison de la stigmatisation, du manque d'informations et de la crainte d'être stigmatisées et discriminées. En l'absence d'un cadre de soins, leurs expériences uniques restent non documentées et mal comprises.

Prestataires de soins de santé et services de santé sexuelle et reproductive inclusifs pour les personnes intersexuées

Les professionnels de santé manquent souvent de formation adéquate sur la santé des personnes intersexuées, en particulier concernant les questions de santé sexuelle et reproductive telles que les menstruations, l'aide à la fertilité et les soins hormonaux (Sanders et al., 2015). Des études font état de mauvaises pratiques cliniques, d'une communication peu sensible et du renforcement des normes binaires de genre (Al-Jurayyan, 2011 ; Ediati et al., 2015a). Au Nigeria, cette situation est encore aggravée par une exposition limitée aux questions liées à l'intersexualité dans les programmes d'études de médecine (Mungadi, 2015).

Les professionnels de santé nigérians sont confrontés à plusieurs obstacles structurels, notamment des taux élevés d'accouchements à domicile, des services de santé sexuelle et reproductive sous-financés et des tabous culturels autour des menstruations (Austin et al., 2015 ; Adelaja, 2011). Cela rend les connaissances, les attitudes et les pratiques des professionnels de santé très importantes pour façonner l'accès des personnes intersexuées à des services de santé sexuelle et reproductive sûrs et valorisants.

Peu de cliniques nigérianes disposent de protocoles pour la santé des personnes intersexuées. Les recherches menées par Intersex Nigeria ont révélé que 85 % des médecins et infirmiers d'un échantillon de 50 hôpitaux avaient été confrontés à une naissance intersexuée au cours des cinq dernières années, mais ne disposaient d'aucune directive ni formation (Intersex Nigeria 2025). Les services généraux de santé menstruelle, tels que les examens gynécologiques, la prise en charge de la douleur et le traitement hormonal, ne sont pas conçus en tenant compte des corps intersexués. En conséquence, les personnes intersexuées sont soit mal diagnostiquées, soit découragées de se faire soigner.

> ***"Selon la variation intersexuée spécifique, les personnes intersexuées peuvent présenter des saignements réguliers (par exemple, les personnes 46,XX atteintes d'hyperplasie congénitale des surrénales) ou aucun saignement (par exemple, le syndrome d'insensibilité aux androgènes, le syndrome de Turner) (Malouf et al., 2010), ou encore des règles irrégulières. Dans de rares cas, des personnes assignées hommes à la naissance peuvent présenter des tissus utérins ou vaginaux et signaler des saignements inexpliqués (Hutson et al., 2012)."***

L'absence de protocoles de santé sexuelle et reproductive (SSR) inclusifs pour les personnes intersexuées compromet non seulement les résultats en matière de santé, mais contribue également à la peur, à la stigmatisation et au report de la recherche de soins chez les personnes intersexuées. L'élaboration d'une procédure opérationnelle standard et l'intégration de la santé des personnes intersexuées dans la formation médicale constituent des étapes essentielles pour garantir un accès équitable aux services de santé menstruelle et de SSR.

Lacunes politiques et obstacles à l'inclusion des personnes intersexuées dans les soins menstruels au Nigeria

Au Nigeria, l'éducation à la santé menstruelle et les cadres politiques sont généralement conçus pour cibler uniquement les filles et les femmes cisgenres, et sont souvent dispensés tardivement, voire pas du tout, en raison des tabous. Les personnes intersexuées peuvent être complètement exclues des discussions sur la santé menstruelle ou des supports d'information sur ce sujet. Dans une étude, des hommes intersexués nigérians ont déclaré ne pas savoir pourquoi ils saignaient chaque mois, pensant au départ qu'il s'agissait d'hématurie (présence de sang due à une maladie) ou de parasites (Sani et al., 2020). Ni leur famille ni leur école ne leur avaient appris à s'attendre à avoir des règles. De même, les femmes intersexuées qui n'ont pas de règles ne découvrent souvent la raison qu'à l'âge adulte. Cette ignorance constitue un obstacle majeur ; sans informations précises, les personnes intersexuées ne peuvent pas gérer leurs règles ou leur aménorrhée, et peuvent se sentir anormales ou effrayées.

La société nigériane impose strictement la binarité des genres. Une personne intersexuée élevée comme un homme qui commence à saigner chaque mois est confrontée à une honte et une peur extrêmes (Sani et al., 2020). Une femme (ou une fille) intersexuée qui n'a jamais de règles peut se sentir isolée, pensant que quelque chose ne va pas avec son corps. Dans les deux cas, les personnes concernées cachent souvent le problème plutôt que de chercher de l'aide. Ce silence dicté par la stigmatisation signifie que les familles et les communautés ne fournissent ni conseils ni ressources.

La politique de santé menstruelle au Nigeria s'est considérablement améliorée ces dernières années, notamment grâce à la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la santé des adolescents et des jeunes et des programmes d'eau, d'assainissement et d'hygiène (WASH). Aucune politique du gouvernement nigérian n'aborde explicitement la santé des personnes intersexuées, et les programmes de santé sexuelle et reproductive (SSR) ne comprennent pas non plus d'indicateurs ou de lignes directrices pour les corps intersexués. Cela crée de multiples obstacles systémiques, comme les programmes de distribution de produits d'hygiène menstruelle qui ne ciblent que les filles et les femmes. L'absence de reconnaissance juridique des personnes intersexuées signifie que leurs droits en matière de SSR sont souvent ignorés dans les protections juridiques.

Dans un pays où la stigmatisation et la désinformation restent omniprésentes, l'absence d'un cadre juridique et politique clair permet la poursuite de la négligence médicale et de l'exclusion sociale des personnes intersexuées (Chow-Quesada 2023). À l'instar d'autres femmes pauvres, les personnes intersexuées au Nigeria peuvent manquer de moyens financiers pour se procurer des produits menstruels de qualité ou bénéficier d'installations sanitaires fiables dans les écoles ou sur les lieux de travail. Les personnes intersexuées qui ne se présentent pas comme des femmes (par exemple, celles assignées de sexe masculin à la naissance) peuvent également ressentir un malaise ou subir une stigmatisation supplémentaire lorsqu'elles se procurent des produits étiquetés « pour femmes ». Bien qu'il n'existe pas de données spécifiques sur l'utilisation des produits menstruels par les personnes intersexuées, il est clair qu'elles sont confrontées à la même précarité menstruelle qui touche de nombreuses filles nigérianes (NigeriaHealthWatch, 2025). Lorsque les produits ou les installations sont rares, les besoins des personnes intersexuées ayant des règles sont encore plus susceptibles d'être ignorés.

Malgré une prise de conscience mondiale accrue de l'équité menstruelle, la plupart des interventions ciblent les filles et les femmes cisgenres, excluant les autres personnes ayant des règles, telles que les personnes intersexuées. Si les études fondamentales sur les pratiques de naissance et de soins au Nigeria fournissent un aperçu des défis plus larges en matière de santé maternelle, elles n'incluent pas les personnes présentant des caractéristiques intersexuées (Envuladu et al., 2013). De même, les études chirurgicales et cliniques se concentrent sur l'attribution précoce du genre, négligeant les besoins psychosociaux et de santé menstruelle qui apparaissent à l'adolescence ou à l'âge adulte (Özbey et al., 2004 ; Al-Jurayyan, 2010).

Cette lacune souligne l'importance de la présente étude, qui vise à mettre en avant les voix et les expériences des personnes intersexuées dans les discussions sur la santé menstruelle, en particulier dans un environnement où la stigmatisation est forte comme au Nigeria.

Les personnes intersexuées et les défis liés à l'accès aux soins

Les militants des droits humains et d'autres organisations de défense des droits ont mis en évidence la marginalisation des personnes intersexuées dans les systèmes de santé à l'échelle mondiale. Au Nigeria, il n'existe aucune collecte de données ni aucun programme mené par le gouvernement pour les personnes intersexuées. Une revue systématique des inégalités en matière de santé et de soins de santé pour les personnes présentant des variations innées des caractéristiques sexuelles suggère que les personnes intersexuées sont plus susceptibles que la population générale de faire état d'expériences défavorables dans l'accès aux soins de santé, an & Aranda, 2020)

notamment une mauvaise communication de la part des professionnels de santé et une insatisfaction vis-à-vis du traitement et des soins reçus. Les professionnels de santé considèrent généralement le binaire masculin-féminin comme la norme et expriment leur surprise lorsqu'ils apprennent l'existence de la variance intersexuée, mais ne savent pas toujours comment répondre aux besoins de santé spécifiques de ces personnes. Leurs besoins de santé sont souvent mal compris par les professionnels de santé en raison de connaissances et d'une compréhension limitées. (Zeeman & Aranda, 2020)

La stigmatisation liée à des organes génitaux ou à des fonctions reproductives atypiques contribue à la détresse psychologique des personnes intersexuées. Celle-ci se manifeste notamment par de l'anxiété, une dépression, des comportements d'automutilation et des idées suicidaires (Schützmann et al., 2009). Lorsqu'elle s'accompagne d'une confusion ou de douleurs liées aux menstruations, cette détresse s'intensifie, en particulier dans les sociétés conservatrices où les menstruations sont taboues. Les personnes intersexuées ont fait part de leurs difficultés à concilier leurs fonctions corporelles avec les attentes normatives, reflétant la même surveillance corporelle que celle subie par les femmes cisgenres, mais avec une complexité et une honte supplémentaires (Guntram 2013).



03 Méthodologie

Conception de la recherche

Cette étude a adopté une approche mixte afin de générer une compréhension globale des expériences en matière de santé menstruelle chez les personnes intersexuées et de la capacité des systèmes de santé à les soutenir, en utilisant à la fois des données quantitatives et qualitatives. La méthode qualitative est appropriée pour étudier des phénomènes peu étudiés ou sensibles pour lesquels il existe peu de données empiriques. Compte tenu de l'invisibilité et de la stigmatisation entourant les identités intersexuées et la santé menstruelle au Nigeria, une méthode quantitative a été utilisée pour les professionnels de la santé, tandis qu'une méthode qualitative, qui permet une compréhension contextuelle approfondie, a été utilisée pour les professionnels de la santé et les personnes intersexuées afin de comprendre les lacunes du système de santé, les expériences vécues et les influences socioculturelles.

Les méthodes qualitatives, en particulier l'analyse phénoménologique interprétative (API), ont joué un rôle déterminant dans la saisie des expériences vécues par les individus (Smith & Osborn, 2015). L'IPA permet aux chercheurs d'explorer la construction du sens autour de la menstruation, de la stigmatisation et des interactions avec les soins de santé. On ne saurait trop insister sur l'importance d'utiliser des approches centrées sur les participants pour des sujets sensibles tels que le genre et l'autonomie corporelle. De plus, une étude de Guest et al. (2006) montre que la saturation des données en recherche qualitative peut être atteinte avec des échantillons de taille relativement réduite lorsque l'on recourt à des entretiens approfondis.

Cette étude a exploré et interprété les expériences vécues en matière de santé menstruelle par des personnes intersexuées ainsi que les points de vue des professionnels de santé dans le contexte sanitaire et socioculturel nigérian.

Population étudiée

L'étude se concentre sur deux populations principales : les personnes intersexuées âgées de 18 ans et plus résidant au Nigeria, afin de répondre à des questions liées aux menstruations, qu'elles aient ou non leurs règles. Et les professionnels de santé, notamment les médecins, les infirmières et les sages-femmes, qui ont pu être en contact avec des personnes intersexuées ou qui interviennent dans les services de santé menstruelle.

Technique d'échantillonnage et taille de l'échantillon

Une méthode d'échantillonnage raisonné a été utilisée pour identifier les personnes intersexuées par le biais des réseaux de soutien d'Intersex Nigeria et des recommandations de pairs. Les professionnels de santé ont été sélectionnés à l'aide de réseaux de référence, en se concentrant sur ceux impliqués dans la santé sexuelle et reproductive, la santé des adolescents ou la gestion de l'hygiène menstruelle.

En raison de la nature hautement sensible des soins et des services liés à l'intersexualité au Nigeria et de la stigmatisation qui entoure la santé sexuelle et reproductive, le recrutement de participants intersexués s'est avéré particulièrement difficile. Douze (12) personnes intersexuées ont participé à des entretiens avec des informateurs clés (KII). Bien que ce nombre puisse paraître faible, il est conforme aux recherches exploratoires menées auprès de populations marginalisées, où l'invisibilité et la crainte de la divulgation limitent la participation.
Les récits recueillis fournissent néanmoins des informations riches et approfondies sur les réalités vécues par les personnes intersexuées, offrant des données qualitatives précieuses pour le plaidoyer et les études futures.

Pour les professionnels de santé, une approche d'échantillonnage mixte a été appliquée. Au total, 65 professionnels de santé issus de différents corps de métier, notamment des médecins, des infirmiers, des sages-femmes et des agents de santé communautaires (CHEW), ont été interrogés afin de recueillir leurs points de vue sur la sensibilisation, les connaissances et la préparation à la prise en charge de la santé menstruelle des personnes intersexuées. Un entretien approfondi a également été mené auprès de 12 professionnels de santé, un médecin et une infirmière pour chaque zone géopolitique. La conception à méthodes mixtes a donc été choisie non pas pour obtenir une représentativité, mais pour générer des données exploratoires, en combinant les tendances quantitatives avec la profondeur qualitative afin de répondre aux questions de recherche.

Méthodes de collecte des données

La principale source de données de cette étude était constituée de données de terrain recueillies directement auprès des prestataires de soins de santé et des personnes intersexuées au Nigeria. Ce recours aux données primaires était essentiel en raison de la disponibilité limitée de données secondaires sur la santé menstruelle des personnes intersexuées dans le contexte nigérian. Cette étude a utilisé une approche à méthodes mixtes afin de saisir à la fois l'étendue et la profondeur des informations sur la santé menstruelle des personnes intersexuées au Nigeria. Les données quantitatives ont été recueillies au moyen d'enquêtes structurées menées auprès de professionnels de santé de différents niveaux (médecins, infirmières, sages-femmes et agents de santé communautaires). Ces enquêtes visaient à évaluer le niveau de sensibilisation, la formation reçue, les attitudes et le niveau de confiance dans la prise en charge des soins menstruels des personnes intersexuées.

Les données qualitatives ont été recueillies par le biais d'entretiens avec des informateurs clés (KII) auprès de personnes intersexuées et de professionnels de santé. Pour les participants intersexués, les entretiens ont porté sur les expériences vécues de la menstruation, l'accès à l'information, les impacts psychosociaux et les obstacles aux soins. Pour les professionnels de santé, les KII ont exploré les perceptions, les lacunes dans les connaissances et les défis systémiques. Cette approche a permis aux participants de partager des récits personnels, des perspectives spécifiques au contexte et des recommandations dans leurs propres mots, enrichissant ainsi les résultats de l'enquête de réalités vécues.

La combinaison des données d'enquête et des entretiens approfondis a permis d'assurer une triangulation, renforçant ainsi la validité des résultats tout en rendant compte à la fois des tendances chiffrées et des expériences nuancées. Cette approche est particulièrement cruciale pour un groupe marginalisé comme les personnes intersexuées, dont les réalités sont souvent invisibles dans les données générales.

Considérations éthiques

Compte tenu de la sensibilité entourant les réalités intersexuées et la santé sexuelle et reproductive, des procédures éthiques strictes ont été suivies tout au long de l'étude. Le consentement éclairé a été obtenu de tous les participants après leur avoir fourni des informations claires sur l'objectif de la recherche, la participation attendue et le caractère volontaire de leur implication. Les participants ont été informés de leur droit de se retirer à tout moment sans pénalité. Nous avons strictement respecté la confidentialité et l'anonymat, aucune forme d'identité n'ayant été enregistrée pour les personnes intersexuées, et les données ont été stockées en toute sécurité.

Compte tenu de la sensibilité des expériences et des réalités intersexuées, des protocoles éthiques rigoureux ont été respectés. Toutes les données enregistrées ont été stockées en toute sécurité pendant l'analyse et supprimées à la fin de l'étude. De plus, les enquêteurs ont été formés aux approches tenant compte des traumatismes et à la nécessité de fournir des ressources de soutien aux participants dans le cas où un répondant se sentirait en détresse pendant les entretiens.

Un document d'orientation a été fourni par Intersex Nigeria sur l'engagement respectueux et inclusif envers les personnes intersexuées afin d'aider les enquêteurs à mener les entretiens et les interactions avec les personnes intersexuées d'une manière qui garantisse la sensibilité, la précision et le respect dans tous les processus.

04

Résultats et analyse

Les résultats de cette étude offrent un aperçu des caractéristiques démographiques, des niveaux de sensibilisation, de la formation, des attitudes et des perceptions concernant l'inclusion des personnes intersexuées dans les services de santé menstruelle, y compris l'expérience vécue par les personnes intersexuées.

Données démographiques des professionnels de santé ayant participé à l'enquête

Rôle professionnel

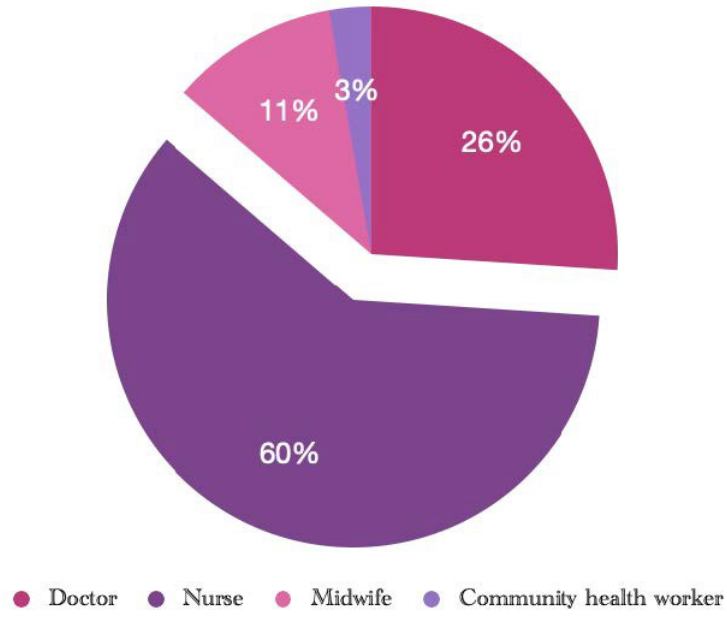
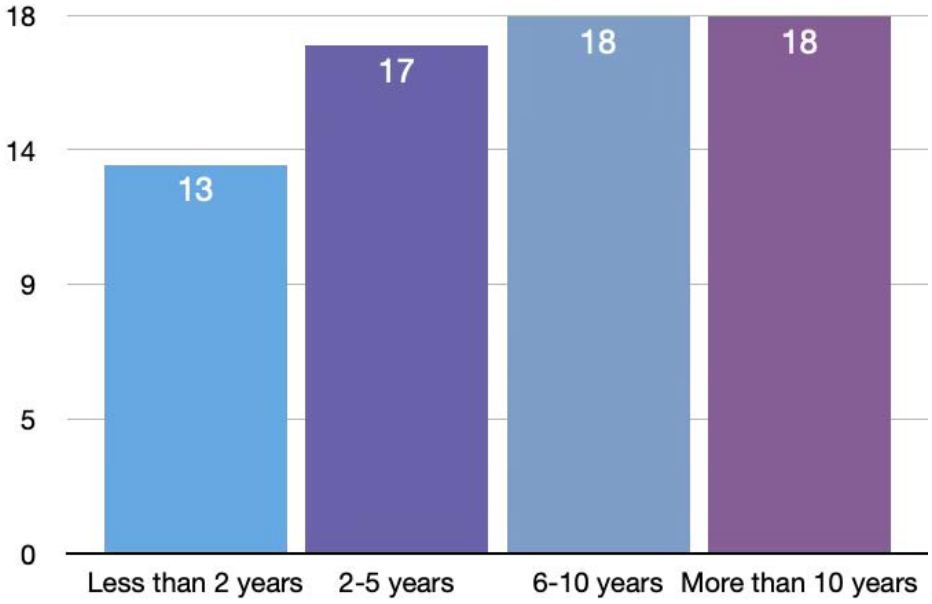


Figure 1 : Professionnels de santé par rôle professionnel

La composition professionnelle des professionnels de santé ayant répondu à l'enquête montre que la majorité d'entre eux étaient des infirmiers et des médecins, représentant plus de 86 % des répondants, tandis que les sages-femmes et les agents de santé communautaires représentaient environ 14 %. Cette répartition reflète la structure typique du personnel de santé de première ligne au Nigeria, où les médecins assurent la supervision médicale et les infirmières jouent un rôle central dans les soins aux patients et la prestation des services. Cette répartition démographique est importante, car elle garantit que les résultats reflètent les points de vue de divers groupes de professionnels de santé impliqués directement ou indirectement dans les services de santé menstruelle et reproductive.

Années d'expérience



Parmi les professionnels de santé ayant participé à l'enquête, 55 % ont plus de 6 ans d'expérience professionnelle, tandis que 25 % ont déclaré avoir entre 2 et 5 ans d'expérience. Seuls 19 % ont moins de 2 ans d'expérience. Cette diversité garantit la fiabilité des résultats, car elle reflète les points de vue de professionnels de santé aussi bien relativement nouveaux dans le système de santé que de professionnels chevronnés ayant une longue expérience.

Figure 2 : Professionnels de santé par années d'expérience

Sensibilisation et connaissances en matière de santé menstruelle des personnes intersexuées

La sensibilisation aux réalités de la santé menstruelle des personnes intersexuées était présente tant chez les professionnels de santé que chez les participants intersexués, bien que le niveau de compréhension varie considérablement. Chez les professionnels de santé, les résultats de l'enquête ont révélé que, bien que le terme « intersexué » soit connu, les connaissances détaillées sur la santé menstruelle des personnes intersexuées étaient limitées et souvent façonnées par des hypothèses binaires. La plupart des professionnels n'avaient jamais reçu de formation formelle ni été exposés aux questions de santé reproductive spécifiques aux personnes intersexuées. Cette lacune découle de l'absence d'intégration des questions intersexuées dans les programmes d'études de médecine et de soins infirmiers, ainsi que de l'absence de directives cliniques ou de formation médicale continue sur le sujet. En conséquence, les professionnels de santé s'appuient souvent sur des cadres conventionnels fondés sur le genre qui ne tiennent pas compte des expériences uniques des personnes intersexuées en matière de santé menstruelle. Cette compréhension limitée affecte leur capacité à fournir des soins respectueux, inclusifs et éclairés lorsque des patients intersexués sollicitent de l'aide pour des préoccupations menstruelles ou reproductives.

Pour les personnes intersexuées, les connaissances sur la menstruation étaient tout aussi limitées, reflétant leur exclusion de l'éducation sexuelle et reproductive traditionnelle. Beaucoup ont fait état de confusion ou de peur lors de leur première expérience de saignements menstruels, ou d'anxiété lorsqu'elles n'avaient pas de règles du tout, malgré les attentes de la société. Pour certaines, la menstruation était initialement perçue comme une maladie ou un événement anormal, tandis que d'autres avaient du mal à interpréter leurs expériences corporelles en raison de l'absence d'informations précises et non stigmatisantes. Ce manque d'éducation adaptée et de conseils tenant compte des spécificités culturelles les a privées des connaissances et des ressources nécessaires pour gérer leurs menstruations en toute sécurité et en toute confiance.

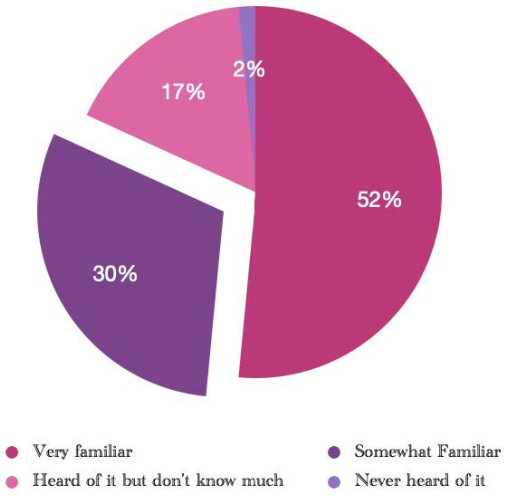


Figure 3 : Familiarité des professionnels de santé avec le terme « intersexué »

Parmi les professionnels de santé interrogés, un grand nombre ont déclaré être très familiers avec ce terme.

L'enquête a montré que si la plupart avaient entendu parler du terme "intersexué", seule une minorité avait une compréhension détaillée des besoins en matière de santé menstruelle des personnes intersexuées. Plus précisément, beaucoup ont reconnu que les questions liées à l'intersexualité étaient rarement abordées dans leur formation officielle, ce qui les laissait dans l'incertitude quant aux soins appropriés à prodiguer. Ce manque de formation a été confirmé lors d'un entretien avec un professionnel de santé qui a déclaré :

> ***« Nous n'avons pas beaucoup appris sur l'intersexualité pendant notre formation, donc lorsque de tels cas se présentent, nous ne savons pas trop comment réagir. »***

Accès à l'information et aux produits menstruels

Pour les personnes intersexuées, la sensibilisation et l'accès à l'information sur les menstruations sont façonnés par une éducation exclusive au genre. De nombreuses personnes intersexuées se souviennent avoir été choquées et désorientées au début, car l'école leur enseignait que"seules les filles ont leurs règles". Une personne a confié :

> ***"Quand j'ai vu du sang pour la première fois, j'ai cru que j'étais malade. Personne ne m'avait dit que cela pouvait m'arriver". »***

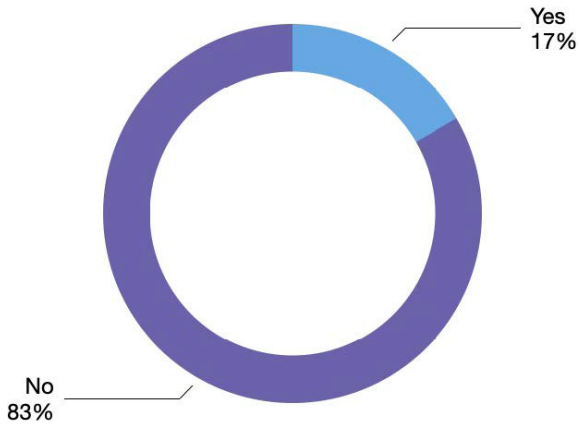


Figure 4 : Professionnels de santé formés à la santé des personnes intersexuées

Malgré cette sensibilisation générale, la plupart des professionnels de santé ont admis n'avoir reçu aucune formation structurée sur la santé des personnes intersexuées. Seuls 11 répondants (17 %) avaient suivi une formation, contre 55 (83 %) qui n'en avaient pas suivi.

Les personnes intersexuées ont indiqué que les informations sur les menstruations étaient principalement acquises de manière informelle, surtout par le biais d'amis ou de la famille, les réalités spécifiques aux personnes intersexuées étant rarement abordées à l'école ou dans l'éducation à la santé. Une personne a déclaré :

> ***"La plupart des informations que j'ai obtenues venaient d'amis, pas d'enseignants ou de médecins".***

L'accès aux produits menstruels a également révélé une situation d'exclusion. Alors que de nombreux professionnels de santé ont confirmé que les produits standard comme les serviettes hygiéniques sont largement promus, de nombreuses personnes intersexuées les trouvaient souvent inconfortables et inadaptés. Une personne a déclaré

> ***"Je ne savais pas quels produits me convenaient ; les serviettes hygiéniques étaient inconfortables, mais je ne savais pas qu'il existait des alternatives".***

Compte tenu de la diversité des corps intersexués et de l'absence de conseils sur les alternatives possibles, telles que les coupes menstruelles ou les options réutilisables, certaines personnes intersexuées considèrent le coût et l'accessibilité comme des obstacles persistants. Une personne interrogée a déclaré avoir complètement abandonné les produits menstruels, affirmant :

> ***"Je n'en utilise plus… Je n'en utilise plus."***

Les personnes intersexuées sont victimes d'une double exclusion, tant sur le plan de l'information que sur le plan matériel, en matière de santé menstruelle. Il existe des lacunes dans l'éducation à la santé menstruelle, aggravées par un manque de diversité et d'accessibilité financière des produits, ce qui conduit à des besoins non satisfaits et à des stratégies d'adaptation improvisées, marginalisant davantage les personnes intersexuées par rapport aux interventions courantes en matière de santé menstruelle.

Interactions avec les prestataires de soins de santé

Les systèmes de santé sont identifiés comme un obstacle à l'accès à des services de santé menstruelle sûrs et adaptés aux personnes intersexuées. Les systèmes de santé constituent un obstacle en raison d'une négligence systémique, telle que l'absence de formation, de politiques et d'infrastructures inclusives pour les questions liées à l'intersexualité, ainsi que par les attitudes des prestataires qui perpétuent la stigmatisation et l'exclusion. La plupart des personnes intersexuées interrogées ont décrit des interactions négatives ou dédaigneuses avec les prestataires. Au lieu de recevoir des conseils ou des soins, les personnes intersexuées se sont souvent senties interrogées ou invalidées. Une personne a raconté :

> *"L'infirmière ne comprenait pas mon corps ; elle n'arrêtait pas de me demander si j'étais vraiment un homme ou une femme au lieu de m'aider".*

Cela révèle des interactions dédaigneuses et stigmatisantes, les prestataires de soins faisant preuve d'une compréhension limitée des réalités intersexuées.

> *"Une fois, j'ai essayé de poser des questions sur mon cycle, mais le médecin m'a écartée en disant : "Ce n'est pas possible pour quelqu'un comme vous."*

Impact psychosocial et stigmatisation

Les personnes interrogées décrivent les menstruations, ou leur absence, comme un lourd fardeau psychosocial, façonné par des attentes sociétales qui invalident les corps intersexués. Les personnes intersexuées ont évoqué l'isolement, le secret et un profond conflit intérieur, découlant de la pression de se conformer à des normes de genre rigides. Une personne intersexuée a déclaré :

> *"J'ai l'impression que mon corps me trahit parce que je ne corresponds pas à ce que les gens attendent."*

Les données de l'enquête ont confirmé cette tendance, montrant que si la majorité des professionnels de santé pensaient que les personnes intersexuées pouvaient avoir leurs règles, une part importante d'entre eux n'en était pas certaine. Seul un très faible pourcentage (5 %) ne croit pas que les personnes intersexuées puissent avoir leurs règles.

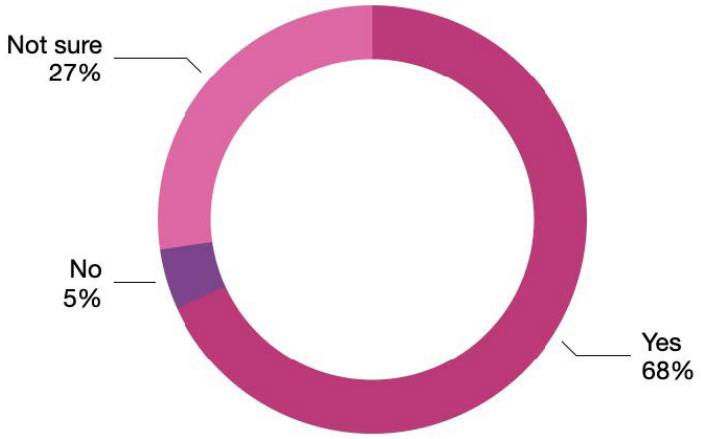


Figure 5 : Perception des professionnels de santé concernant les menstruations chez les personnes intersexuées

Une autre personne a déclaré :

> *"J'ai gardé cela secret pendant des années, même auprès de ma famille, parce que je ne voulais pas être considérée comme bizarre"*

Ces témoignages révèlent que les personnes intersexuées subissent une stigmatisation à plusieurs niveaux, liée à la fois à leur identité et à la menstruation elle-même. Le jugement et la discrimination sont également apparus comme des phénomènes récurrents, une personne intersexuée ayant admis avoir été jugée :

> *"Oui… (en réponse au fait d'être traité injustement).*

En ce qui concerne le soutien, certaines personnes intersexuées ont déclaré trouver réconfort et soutien au sein de leur famille proche. Contrairement à la plupart des personnes intersexuées interrogées, une personne a identifié ses parents comme une source de soutien :

> *"C'est mon papa et ma maman."*

Si le soutien familial peut constituer un facteur de protection dans certains cas, l'absence de systèmes de soutien plus larges, fondés sur les pairs et la communauté, accroît la vulnérabilité à la honte, au secret et à des problèmes de santé mentale.

Attitudes et lacunes dans la prestation des services

Les professionnels de santé ont souvent présenté les menstruations comme un sujet concernant uniquement les filles et les femmes, reflétant ainsi les orientations binaires profondément ancrées des systèmes de santé sexuelle et reproductive. Certains ont reconnu l'existence de pratiques d'exclusion, notant que les personnes intersexuées sollicitent rarement des services, peut-être par crainte de la stigmatisation.
Un prestataire a déclaré :

> *« Nous les voyons rarement dans notre établissement. Peut-être ne viennent-elles pas parce qu'elles savent que nous ne sommes pas préparés à les accueillir. »*

De tels sentiments révèlent à la fois un malaise au niveau des prestataires et des obstacles systémiques plus larges qui découragent les personnes intersexuées de solliciter des services de santé essentiels.

Rencontres des professionnels de santé avec une personne intersexuée sollicitant des soins pour des problèmes menstruels ou connexes

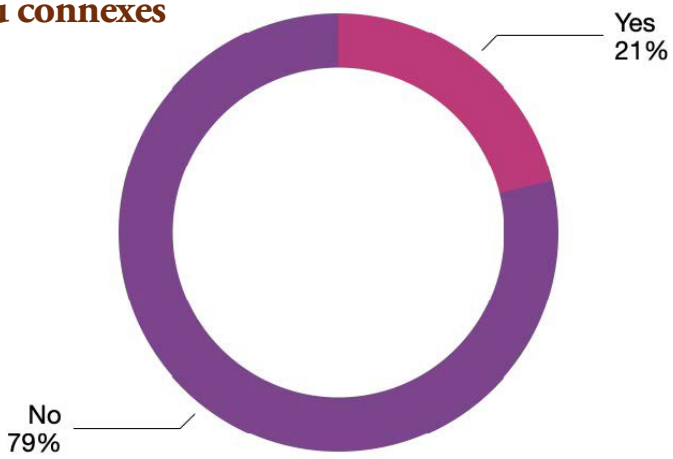


Figure 6 : Montre les professionnels de santé ayant rencontré des personnes intersexuées présentant des problèmes menstruels

Les résultats concernant les rencontres cliniques montrent que seuls quelques professionnels de santé ont déclaré avoir déjà pris en charge une personne intersexuée présentant des problèmes liés aux menstruations, tandis que la grande majorité d'entre eux n'avait jamais rencontré un tel cas. Cela s'explique soit par le fait que les personnes intersexuées sollicitent rarement des soins pour leurs besoins en matière de santé menstruelle en raison de la stigmatisation, du manque de confiance ou de leur invisibilité au sein du système de santé, soit par le fait que les cas peuvent passer inaperçus parce que les professionnels de santé ne sont pas suffisamment formés pour identifier les variations intersexuées.

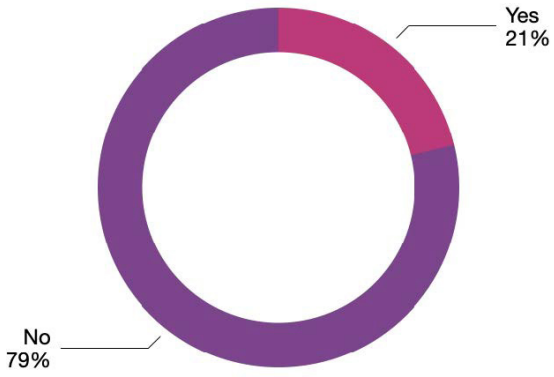


Figure 8 : Réponses des professionnels de santé concernant l'existence de directives claires sur le lieu de travail relatives à la santé menstruelle des personnes intersexuées

En ce qui concerne la préparation du lieu de travail, lorsqu'on leur a posé des questions sur les directives en vigueur, seuls 37 répondants (57 %) ont déclaré disposer de protocoles clairs, tandis que 17 (26 %) ont répondu par la négative et 11 (17 %) se sont dits incertains.

Confiance dans la prise en charge des soins menstruels chez les patientes intersexuées

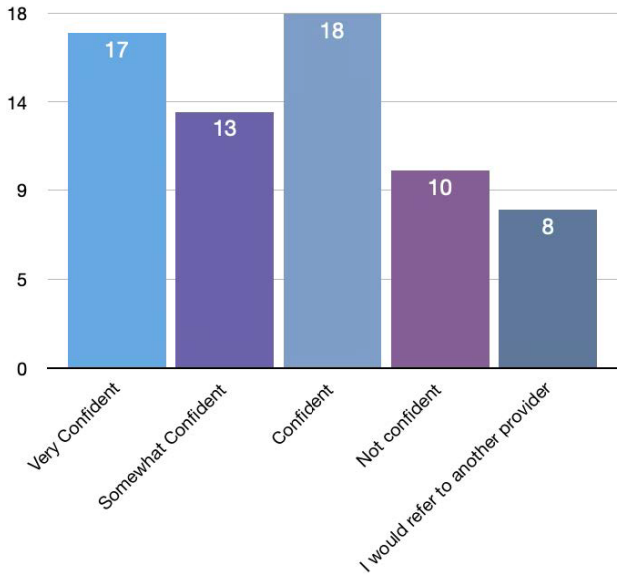


Figure 7 : Confiance des professionnels de santé dans la prise en charge des soins menstruels des patients intersexués

Que les professionnels de santé aient ou non déjà rencontré des patientes intersexuées, leur confiance dans la prise en charge des soins menstruels de ces patientes révèle que, si un bon nombre d'entre eux se sentent en confiance, quelques-uns ne le sont pas, et certains préféreraient orienter ces cas vers un autre prestataire. Bien que plus de la moitié des personnes interrogées se disent confiantes dans la gestion de la santé menstruelle des personnes intersexuées, une part importante reste incertaine ou réticente à prendre en charge de tels cas.

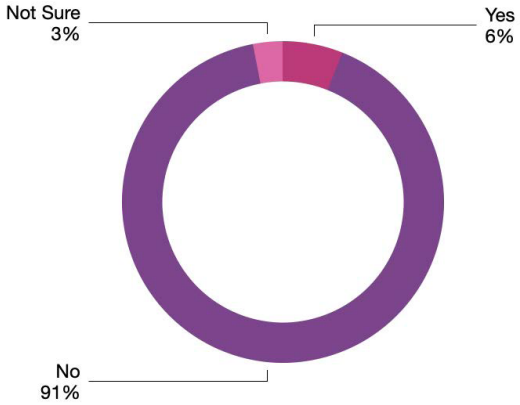


Figure 9 : Réponses concernant la réception par les professionnels de santé de protocoles cliniques ou de ressources sur la santé menstruelle des personnes intersexuées

De même, seuls 4 professionnels de santé (6 %) avaient déjà reçu un protocole clinique ou une ressource sur la santé menstruelle des personnes intersexuées. Cela montre qu'il existe une absence quasi totale d'outils structurés et pratiques au sein du système de santé pour guider les prestataires dans la prestation de soins inclusifs pour les personnes intersexuées.

Obstacles aux soins inclusifs

L'exclusion des personnes intersexuées est principalement due à la fois aux attitudes sociales et aux défaillances systémiques, la stigmatisation et la formation insuffisante des prestataires constituant les obstacles les plus critiques.

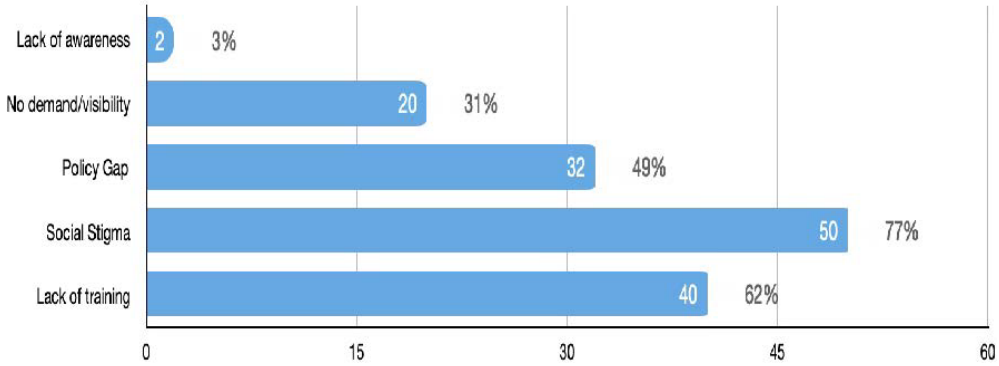


Figure 10 : Réponses concernant les obstacles à l'inclusion des personnes intersexuées dans les soins de santé menstruelle

La stigmatisation sociale et le manque de formation des professionnels de santé sont identifiés comme les principaux défis à surmonter pour des soins de santé menstruelle inclusifs destinés aux personnes intersexuées. Parmi les autres obstacles figurent la faible visibilité ou la faible demande de services spécifiques aux personnes intersexuées et, dans une moindre mesure, le manque de sensibilisation. L'importance relativement moindre accordée au manque de sensibilisation suggère que, bien que les questions liées à l'intersexualité soient quelque peu reconnues, l'absence de politiques de soutien et de capacités professionnelles reste le principal obstacle à des soins de santé menstruelle inclusifs.

Afin de mieux comprendre en profondeur les obstacles à des soins inclusifs pour les personnes intersexuées, nous avons examiné les entretiens dans lesquels les professionnels de santé ont fortement insisté sur la stigmatisation et le jugement de la part des prestataires comme obstacle majeur, ces derniers reconnaissant que de telles attitudes découragent les personnes intersexuées de solliciter des soins. De plus, plusieurs personnes interrogées ont souligné que le manque de formation et de directives cliniques explicites contribue encore davantage à l'exclusion, car la plupart s'appuient sur des protocoles généraux de santé sexuelle et reproductive qui ne mentionnent pas les besoins spécifiques des personnes intersexuées. Cette absence d'orientation structurée rend les prestataires incertains et hésitants dans leur pratique. Un professionnel de santé a expliqué que

"S'il existait des politiques ou des manuels clairs, cela nous aiderait à savoir quoi faire."

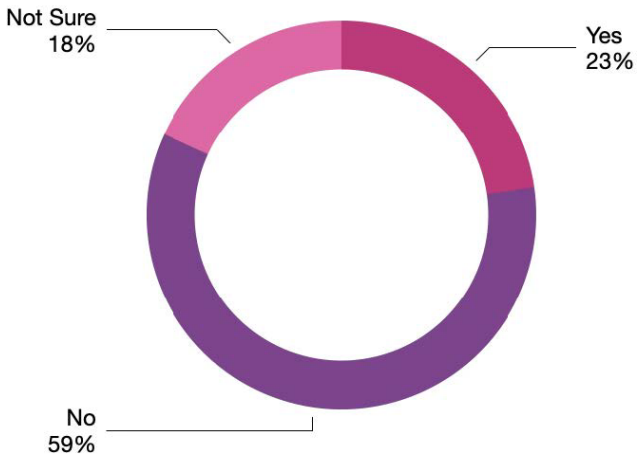


Figure 11 : Opinions des professionnels de santé sur la prise en compte des besoins des personnes intersexuées dans les services actuels de santé sexuelle et reproductive

Pour éclaircir la question de savoir si les services actuels de santé sexuelle et reproductive (SSR) au Nigeria prennent suffisamment en compte les besoins des personnes intersexuées, les réponses font apparaître des points de vue divergents parmi les professionnels de santé. Alors qu'un grand nombre de personnes interrogées estimaient que les services de SSR répondaient bien aux besoins des personnes intersexuées, une proportion considérable d'entre elles estimaient que ce n'était pas le cas, et d'autres encore n'étaient pas sûres.

Inclusion et lacunes politiques

Lorsqu'elles ont évoqué l'inclusion en matière de santé menstruelle, les personnes intersexuées ont systématiquement souligné leur invisibilité et leur exclusion au sein des cadres éducatifs, sanitaires et politiques existants. Les écoles et les systèmes de santé sont perçus comme renforçant une conception binaire de la menstruation, laissant les personnes intersexuées sans reconnaissance ni soutien. Les personnes intersexuées ont souligné l'importance de réformer l'éducation :

"Les écoles devraient enseigner que les filles ne sont pas les seules à avoir leurs règles. Cela m'aurait permis de me sentir normal."

S'il est nécessaire de réformer le secteur de l'éducation, il est également nécessaire de renforcer les capacités dans le secteur de la santé :

"Nous avons besoin que les professionnels de santé soient formés pour comprendre nos corps, et non pour nous juger."

Les types de soutien qui, selon les professionnels de santé, leur permettraient de fournir de meilleurs soins aux personnes intersexuées qui ont leurs règles varient, avec une forte demande en matière de renforcement des capacités et d'orientation systémique. L'enquête montre que la majorité des personnes interrogées ont souligné la nécessité d'une formation médicale continue, d'un mentorat par des spécialistes et de l'élaboration de directives cliniques nationales.

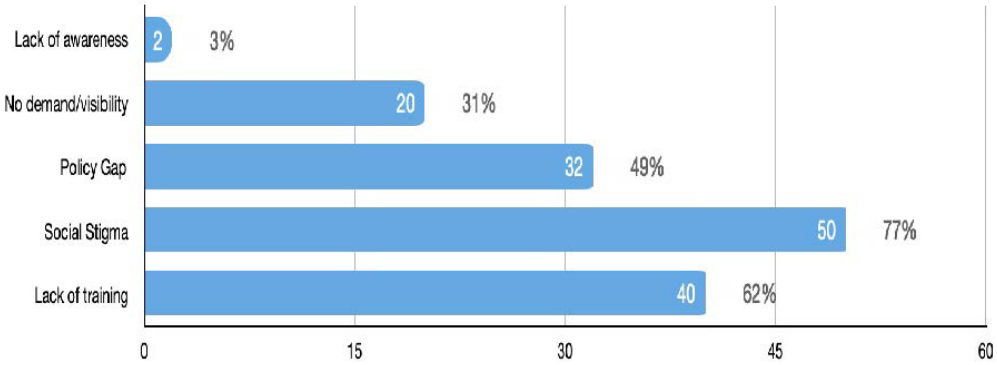


Figure 12 : Réponses concernant le soutien nécessaire pour offrir de meilleurs soins aux personnes intersexuées qui ont des règles

Ces résultats montrent qu'il existe un besoin urgent de réformes politiques et programmatiques qui dépassent les modèles binaires de la santé menstruelle. L'inclusion nécessite des stratégies globales qui intègrent les réalités intersexuées dans les programmes scolaires, la formation des professionnels de santé et les politiques nationales en matière de santé sexuelle et reproductive, afin de garantir que les personnes intersexuées soient reconnues, soutenues et autonomisées.

05

Discussion, conclusions et recommandations

Discussion des résultats

Cette étude a exploré les besoins et les expériences en matière de santé menstruelle des personnes intersexuées au Nigeria, ainsi que les connaissances, les attitudes et les pratiques des professionnels de santé qui fournissent des services de santé sexuelle et reproductive (SSR). L'étude révèle des lacunes importantes en matière de sensibilisation, de formation, de prestation de services et d'inclusion, avec des conséquences psychosociales importantes pour les personnes intersexuées. Les résultats montrent que les personnes intersexuées au Nigeria vivent leurs menstruations de manière variée et souvent irrégulière. Leurs premières expériences ont été marquées par la peur et la confusion en raison de la conception exclusive des menstruations comme une expérience réservée aux filles. L'accès limité à des informations précises, l'exclusion des programmes scolaires et le manque de produits menstruels adaptés ont encore renforcé la stigmatisation et le secret.

Les défis psychosociaux, notamment la honte, l'isolement et le secret, soulignent l'absence de soutien communautaire ou institutionnel.

L'étude a également révélé que les professionnels de santé connaissent le concept d'intersexualité, mais manquent de connaissances pratiques ou d'outils pour prendre en charge la santé menstruelle des personnes intersexuées. Seule une petite fraction d'entre eux avait reçu une formation ou des protocoles cliniques, et beaucoup ont exprimé un malaise ou ont préféré orienter les cas vers d'autres spécialistes. La stigmatisation et le jugement ont souvent été reconnus comme des obstacles, tandis que la négligence des politiques a perpétué l'invisibilité. Cependant, les professionnels ont exprimé leur volonté de s'améliorer, en appelant à une formation médicale continue, à un mentorat et à des directives nationales.

Conclusions

Cette étude conclut que les personnes intersexuées restent largement invisibles dans le paysage de la santé menstruelle au Nigeria, confrontées à l'exclusion de l'éducation, des soins de santé et des politiques. Les entretiens avec les professionnels de santé montrent que, bien que la notion d'intersexualité soit connue des prestataires de soins, leurs connaissances restent superficielles, la plupart d'entre eux n'ayant pas une compréhension détaillée des besoins en matière de santé menstruelle des personnes intersexuées. Ces connaissances limitées sont aggravées par une stigmatisation et une exclusion profondément enracinées, car tant les normes sociales que les préjugés des prestataires, renforcés par des cadres binaires de santé sexuelle et reproductive (SSR), continuent de marginaliser les personnes intersexuées. Les professionnels de santé, bien que motivés, sont mal préparés en raison

d'une négligence systémique, de la stigmatisation et du manque de ressources. Pour relever ces défis, une réponse globale est nécessaire, combinant réforme des politiques, formation des prestataires, réduction de la stigmatisation et mécanismes de soutien psychosocial.

De plus, la négligence politique perpétue l'invisibilité, car les questions spécifiques aux personnes intersexuées restent absentes des politiques de santé sexuelle et reproductive et des programmes nationaux, ce qui entraîne une exclusion systémique. Au niveau personnel et communautaire, les personnes intersexuées sont confrontées à de profonds défis psychosociaux, souvent marqués par le secret, la honte et l'isolement, avec un accès limité aux systèmes de soutien par les pairs, la famille ou les institutions. Ces lacunes ayant été identifiées, il est urgent de mettre en place des réformes globales portant sur la formation, la stigmatisation, les politiques et le soutien psychosocial afin de garantir l'inclusion des personnes intersexuées dans la santé menstruelle.



Recommendations

Réforme politique et institutionnelle

- Le gouvernement devrait envisager d'intégrer les besoins des personnes intersexuées dans les politiques nationales de santé sexuelle et reproductive (SSR), en incluant explicitement ces personnes dans les cadres relatifs à la santé sexuelle et reproductive (SSR), à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène (WASH) et à la santé menstruelle.
- Les autorités nationales devraient élaborer des directives cliniques et des protocoles clairs sur la prise en charge de la santé menstruelle des personnes intersexuées.
- Les établissements de santé doivent adopter des directives inclusives sur le lieu de travail traitant de la stigmatisation, de la dignité des patients et de la confidentialité.

Renforcement du système de santé

- Mettre en place une formation médicale continue régulière en cours d'emploi sur la santé des personnes intersexuées, en mettant l'accent sur la santé menstruelle.
- Fournir des manuels conviviaux et des outils d'aide à la décision pour aider les prestataires à dispenser des soins inclusifs.

Soutien psychosocial et communautaire

- Soutenir les organisations et réseaux communautaires qui fournissent un soutien psychosocial, un mentorat par les pairs et des orientations vers des services spécialisés.
- Intégrer les services de santé mentale dans les soins de santé sexuelle et reproductive, en s'attaquant à la stigmatisation, au secret et à la honte dont font état les personnes intersexuées.

Accès à la santé menstruelle et soutien en matière de produits

- Élargir les programmes de produits menstruels pour inclure les personnes intersexuées, en garantissant l'accès à des produits confortables et sûrs.
- Fournir des conseils personnalisés sur le choix des produits, en tenant compte des différences anatomiques et de confort entre les personnes intersexuées.

Sensibilisation du public et réduction de la stigmatisation

- Lancer des campagnes visant à réduire la stigmatisation en soulignant que les menstruations ne concernent pas uniquement les « filles et les femmes », mais peuvent également toucher les personnes intersexuées.
- Mettre en place des initiatives dans les médias et auprès des communautés visant à normaliser la diversité corporelle et à promouvoir l'acceptation.
- Impliquer les chefs religieux, traditionnels et communautaires dans la promotion de l'inclusion et du respect des personnes intersexuées.

Éducation et formation

- Réviser les programmes scolaires sur la santé menstruelle afin de refléter la diversité corporelle et de réduire l'aliénation des élèves intersexués.
- Assurer un développement professionnel continu grâce à des ateliers interdisciplinaires sur les soins inclusifs pour les personnes intersexuées.

Partenariats stratégiques et plaidoyer

- Renforcer les partenariats entre les groupes dirigés par des personnes intersexuées, les mouvements féministes et les organisations de santé sexuelle et reproductive afin d'accroître la visibilité.
- Utiliser les résultats de la recherche pour impliquer les décideurs politiques, les bailleurs de fonds et les associations professionnelles dans une planification inclusive de la santé menstruelle.

Appel à l'action : des données à l'équité

Combler le fossé en matière de santé menstruelle des personnes intersexuées au Nigeria

Les conclusions de ce rapport présentent des preuves indéniables : les personnes intersexuées au Nigeria sont confrontées à un système de santé qui les rend invisibles, à des systèmes éducatifs qui effacent leur réalité et à une société qui stigmatise leur corps.

Cette recherche ne doit pas rester lettre morte. C'est un outil de transformation. Nous appelons les parties prenantes suivantes et toutes les autres parties intéressées à s'appuyer sur ces résultats et à prendre des mesures concrètes et mesurables pour combler le fossé entre les données factuelles et le plaidoyer.

1. À l'intention du ministère fédéral de la Santé et des décideurs politiques

- **Reconnaître et institutionnaliser:** Reconnaître officiellement les personnes intersexuées dans les cadres politiques nationaux relatifs à la santé sexuelle et reproductive (SSR) et à la gestion de la santé menstruelle (GSM).

  Action: réviser la définition du terme « personnes menstruées » dans les documents nationaux afin d'inclure toutes les personnes qui ont des saignements, et pas seulement les « femmes et les filles ».

- **Normaliser les protocoles cliniques:** Les recherches indiquent que 91 % des professionnels de santé n'ont jamais reçu de protocoles cliniques sur la santé menstruelle des personnes intersexuées.

  Action: Réunir un groupe de travail technique, comprenant des militants intersexués et des spécialistes médicaux, afin de rédiger et de diffuser une procédure opérationnelle standard (SOP) nationale pour la prise en charge des personnes intersexuées, traitant spécifiquement des douleurs menstruelles, de l'aménorrhée et des variations hormonales, entre autres exigences et besoins médicaux liés à l'intersexualité.

- **Rendre obligatoire l'inclusion des données:** combler le manque de données en incluant des indicateurs intersexués dans les enquêtes démographiques nationales sur la santé. On ne peut pas planifier pour une population que l'on ne recense pas.

2. À l'intention des organismes professionnels de santé (NMA, NANNM, SOGON, NMDC)

- **Donner la priorité à la formation axée sur les compétences:** 83 % des professionnels de santé interrogés déclarant n'avoir reçu aucune formation préalable sur la santé des personnes intersexuées, l'ignorance constitue un obstacle majeur.

  Action: Intégrer des modules sur la santé des personnes intersexuées dans les programmes obligatoires de formation médicale continue (FMC) et de développement professionnel continu (DPC) destinés aux médecins, infirmiers et sages-femmes.

- **Créer des réseaux de mentorat:** les professionnels de santé ont identifié le « mentorat par des spécialistes » (71 %) comme un besoin prioritaire.

  Action: Mettre en place un parcours d'orientation et de mentorat permettant aux médecins généralistes de consulter des spécialistes (endocrinologues, urologues, psychologues) formés aux soins aux personnes intersexuées fondés sur les droits.

3. À l'intention des organisations de la société civile (OSC) et des défenseurs des droits sexuels et reproductifs

- **Intégrer, ne pas isoler:** cesser de traiter les questions intersexuées comme un sujet de niche.

  Action: : Revoyez vos programmes existants en matière de santé menstruelle, vos campagnes WASH et vos interventions contre la précarité menstruelle. Assurez-vous que votre langage (« les personnes qui ont leurs règles ») et vos images reflètent la diversité de genre.

- **Plaidez en faveur de la diversité des produits:** les recherches soulignent que les serviettes hygiéniques standard sont souvent inconfortables ou provoquent une dysphorie chez les personnes intersexuées.

  Action: lors de vos campagnes de distribution de produits, incluez des produits menstruels alternatifs (tels que des tampons, des coupes menstruelles ou des sous-vêtements menstruels) et proposez une formation sur leur utilisation.

- **Faire entendre la voix des personnes intersexuées:** utilisez les témoignages de ce rapport pour remettre en question le récit unique de la menstruation.

Action: collaborez avec Intersex Nigeria pour co-organiser des ateliers de sensibilisation, en veillant à ce que ce soient les personnes intersexuées elles-mêmes qui racontent leur histoire.

4. À l'intention des établissements d'enseignement et des concepteurs de programmes scolaires

- **Briser le binaire en biologie:** les participant·e·s intersexuées ont déclaré se sentir « trahi·e·s » et « mal à l'aise » parce qu'on leur avait enseigné que les règles ne concernaient que les filles.

  Action: Réviser les programmes d'enseignement des sciences fondamentales et d'éducation à la santé afin d'enseigner avec précision la diversité biologique humaine. Enseigner aux élèves que les corps se présentent sous une forme de spectre, afin de réduire le choc et la honte pour les enfants intersexués qui atteignent la puberté.

- **Environnements scolaires sûrs:**

  Action: Veiller à ce que les installations sanitaires et d'hygiène dans les écoles offrent intimité et sécurité à tous les élèves, quelle que soit leur expression de genre, afin de réduire l'absentéisme chez les jeunes intersexués.

5. À l'attention des donateurs et des partenaires de développement

- **Financer l'invisible:** le manque de données à grande échelle constitue un obstacle au changement de politique.

  Action: Allouer des fonds spécifiques à des études de prévalence quantitatives à grande échelle et à des recherches longitudinales sur les résultats de santé des personnes intersexuées au Nigeria.

- **Soutenir les interventions psychosociales:** L'étude met en évidence un isolement profond et des difficultés en matière de santé mentale.

  Action: Financer des systèmes de soutien psychosocial menés par les communautés, des groupes de soutien par les pairs et des services de santé mentale spécialement adaptés aux personnes intersexuées.

6. À l'attention des médias et des acteurs communautaires influents

- **Changer le discours:**

  Action: Évitez les reportages à sensation. Utilisez ce rapport pour rédiger des articles fondés sur des données factuelles qui humanisent les expériences des personnes intersexuées, en démystifiant l'idée selon laquelle les caractéristiques intersexuées seraient des « malédictions » ou de « mauvais augures ».

- **Normaliser la diversité:**

  Action: Utilisez une terminologie correcte. Évitez les étiquettes péjoratives et aidez le public à comprendre que les variations intersexuées font naturellement partie de la biologie humaine.

Comment utiliser ce rapport pour un impact immédiat

- **Pour le plaidoyer:** Citez les statistiques sur la réticence des prestataires et le manque de formation dans les demandes de subventions et les notes d'orientation afin de justifier la nécessité d'un financement et de programmes urgents.
- **Pour la formation:** : utilisez la section « Expériences vécues » comme études de cas dans la formation médicale afin de développer l'empathie et la compréhension chez les étudiants.
- **Pour le renforcement communautaire:** Partagez les conclusions avec les réseaux intersexués afin de valider leurs expériences, en leur prouvant qu'ils ne sont pas seuls et que leur santé compte.

Le temps du silence est révolu. L'heure est venue d'agir de manière inclusive.

Références

- Adelaja L. M. (2011). A survey of home delivery and newborn care practices among women in a suburban area of Western Nigeria. ISRN Obstetrics and Gynaecology, 2011, 983542. https://doi.org/10.5402/2011/983542
- Åkerman E, Wängborg A, Persson M, Sörensdotter R, Klingberg-Allvin M. (2024) Navigating menstrual stigma and norms: a qualitative study on young people's menstrual experiences and strategies for improving menstrual health. BMC Public Health. Dec 17;24(1):3401. doi: 10.1186/s12889-024-20936-5.
- Al-Jurayyan N. A. (2010). Ambiguous genitalia, two decades of experience: Clinical management and sex assignment. Journal of Taibah University Medical Sciences, 5(1), 13–20. https://doi.org/10.1016/S1658-3612(10)70119-0
- Al-Jurayyan N. A. (2011). Ambiguous genitalia: Two decades of experience. Annals of Saudi Medicine, 31(3), 284–288. https://doi.org/10.4103/0256-4947.81544
- Austin A., Fapohunda B., Langer A., & Orobaton N. (2015). Trends in delivery with no one present in Nigeria between 2003 and 2013. International Journal of Women's Health, 7, 345–356. https://doi.org/10.2147/IJWH.S79573
- Boyle M. E., Smith S., & Liao L. M. (2005). Adult genital surgery for intersex: A solution to what problem? Journal of Health Psychology, 10(4), 573–584. https://doi.org/10.1177/1359105305053431
- Chadwick P. M., Liao L. M., & Boyle M. E. (2005). Size matters: Experiences of atypical genital and sexual development in males. Journal of Health Psychology, 10(4), 529–543. https://doi.org/10.1177/1359105305053420
- Chow-Quesada, Emily. (2023). Canonizing the Mundane: Narrating and Transgressing the Nigerina Queer Self/Selves in Unoma Azuah's Embracing My Shadow: Growing up Lesbian in Nigeria and Chike Frankie Edozien's Lives of Great Men: Living and Loving as an African Gay Man. Prose Studies. 42. 1-29. 10.1080/01440357.2022.2145837
- Dubey, Priyanka & Sivakami, M. & Watkins, Shannon & Baker, Kelly & Story, William & Afifi, Rima. (2024). A qualitative inquiry into the lived experiences of menstrual health and hygiene in the transgender and non-binary people in urban areas of India. International Journal of Transgender Health. 26. 10.1080/26895269.2024.2362915.
- Ediati A., Juniarto A. Z., Birnie E., Drop S. L., Faradz S. M., & Dessens A. B. (2015a). Body image and sexuality in Indonesian adults with a disorder of sex development (DSD). The Journal of Sex Research, 52(1), 15–29. https://doi.org/10.1080/00224499.2013.816260
- Eleesha Lockett 2024 Exploring the Spectrum of Intersex Variations https://www.healthline.com/health/transgender/types-of-intersex
- Envuladu E. A., Agbo H. A., Lassa S., Kigbu J. H., & Zoakah A. I. (2013). Factors determining the choice of a place of delivery among pregnant women in Russia village of Jos North, Nigeria: Achieving the MDGs 4 and 5. International Journal of Medicine and Biomedical Research, 2(1), 23–27.
- Guest G., Bunce A., & Johnson L. (2006). How many interviews are enough? An experiment with data saturation and variability. Field Methods, 18(1), 59–82. https://doi.org/10.1177/1525822X05279903
- Guntram L. (2013). "Differently normal" and "normally different": Negotiations of female embodiment in women's accounts of 'atypical' sex development. Social Science & Medicine, 98, 232–238. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2013.09.018
- Human Rights Watch (2024). Knight, K., "United Nations passes groundbreaking intersex rights resolution," Apr 4, 2024 hrw.org.
- Human Rights Watch. (2017). "I Want to Be Like Nature Made Me"—Medically Unnecessary Surgeries on Intersex Children in the US.

- Hutson J. M., Warne G. L., & Grover S. R. (2012). The adolescent or young adult with DSD. In Hutson J. M., Warne G. L., & Grover S. R. (Eds.), Disorders of sex development (pp. 125–131). Berlin/Heidelberg, Germany: Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-22964-0_13
- Jones, T., et al. (2016). Intersex: Stories and Statistics from Australia. Open Book Publishers.
- Lee, P. A., et al. (2006). Consensus Statement on Management of Intersex Disorders. Pediatrics.
- Malouf M. A., Inman A. G., Carr A. G., Franco J., & Brooks L. M. (2010). Health-related quality of life, mental health and psychotherapeutic considerations for women diagnosed with a disorder of sexual development: Congenital adrenal hyperplasia. International Journal of Pediatric Endocrinology, 2010(1), 253465. https://doi.org/10.1155/2010/253465
- Mazur, T, Bean, E.J, Robinson, A.D. Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Syndrome: Sexuality, Psychological Effects, and Quality of Life Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, Volume 22, Issue 6, 339 - 346 https://doi.org/10.1016/j.jpag.2008.11.006
- Mungadi I. A. (2015). Intersexuality, gender and sex reassignment: A fascination in urologic reconstruction. Sokoto, Nigeria: Graphic Concept Academy.
- Muskan T, 2024 Transgender persons and structural intersectionality: Towards menstrual justice for all menstruators in India DOI:10.20529/IJME.2024.015
- Nigeria Health Watch (2025). "Ending Period Poverty in Nigeria: The Role Men Must Now Play." May 30, 2025 articles.nigeriahealthwatch.com.
- Olasehinde, Tolamise & Funmi, Akinsehinde. (2025). The Role of Government Policies in Improving Menstrual Health and Hygiene Education in Nigeria.
- Outright International (2024). Obioma Chukwuike "Embracing Realities of Sex Development: Challenges and Achievements of Intersex Activism in Nigeria and Beyond." Oct 28, 2024 outrightinternational.orgoutrightinternational.org.
- Özbey H., Darendeliler F., Kayserili H., Korkmazlar Ü., & Salman T. (2004). Gender assignment in female congenital adrenal hyperplasia: A difficult experience. BJU International, 94(3), 388–391. https://doi.org/10.1111/j.1464-410X.2004.04967.x
- Plan International USA (2024). "Periods through the ages: Nigeria." May 22, 2024 planusa.orgplanusa.org.
- Rebelo E., Szabo C. P., & Pitcher G. (2008). Gender assignment surgery on children with disorders of sex development: A case report and discussion from South Africa. Journal of Child Health Care, 12(1), 49–59. https://doi.org/10.1177/1367493507085618
- Sanders C., & Carter B. (2015). A qualitative study of communication between young women with disorders of sex development and health professionals. Advances in Nursing, 2015, 653624. https://doi.org/10.1155/2015/653624
- Sanders C., Carter B., & Lwin R. (2015). Young women with a disorder of sex development: Learning to share information with health professionals, friends and intimate partners about bodily differences and infertility. Journal of Advanced Nursing, 71(8), 1904–1913. https://doi.org/10.1111/jan.12661
- Sani A. et al. (2020). "Women with amenorrhea and men with menstruation: The qualitative experiences of people with disorders of sex development in Nigeria." J Nurs Res 28(1):e67 journals.lww.comjournals.lww.com.
- Schützmann K., Brinkmann L., Schacht M., & Richter-Appelt H. (2009). Psychological distress, self-harming behavior, and suicidal tendencies in adults with disorders of sex development. Archives of Sexual Behavior, 38(1), 16–33. https://doi.org/10.1007/s10508-007-9241-9

- Smith J. A., & Osborn M. (2015). Interpretative phenomenological analysis as a useful methodology for research on the lived experience of pain. British Journal of Pain, 9(1), 41–42. https://doi.org/10.1177/2049463714541642
- The Nation Nigeria (2025). Anofi, D., "FG moves to mainstream Intersex Nigerians in national health agenda," Apr 15, 2025 thenationonlineng.netthenationonlineng.net.
- UN Free & Equal (UNFE). (2017). Fact Sheet: Intersex.. https://www.unfe.org/en/know-the-facts/challenges-solutions/intersex
- UN OHCHR. (2015). Violations of Intersex Human Rights—UN Expert Reports.
- Warne G. L., & Raza J. (2008). Disorders of sex development (DSDs), their presentation and management in different cultures. Reviews in Endocrine and Metabolic Disorders, 9(3), 227–236. https://doi.org/10.1007/s11154-008-9084-2
- World Health Organization (2022). "Statement on menstrual health and rights," 22 June 2022 who.int.
- Woodward M., & Neilson A. (2013). Disorders of sex development. Surgery (Oxford), 31(12), 646–651. https://doi.org/10.1016/j.mpsur.2013.10.005
- Zeeman L, Aranda K. A Systematic Review of the Health and Healthcare Inequalities for People with Intersex Variance. Int J Environ Res Public Health. 2020 Sep 8;17(18):6533. doi: 10.3390/ijerph17186533. PMID: 32911732; PMCID: PMC7559554.
- https://www.linkedin.com/posts/intersexnigeria_intersex-intersexnigeria-intersexbirths-activity-7292106041247334400-w5Jp#:~:text=Curious%20to%20find%20out%20about,Stay%20informed%20on%20an%20often



Ce document a été élaboré et publié par Intersex Nigeria.
website: intersexnigeria.org
email: info@intersexnigeria.org